

Oncología · Desgloses MIR

42 preguntas · Bloque 1: 30 · Bloque 2: 12

Enunciados, opciones y respuestas indicadas por el campus CTO. Se conservan la convocatoria y la clasificación mostradas en el campus.

Bloque 1 / 30 preguntas

Pregunta 130 · MIR 2025 - 2026

Asignatura: Oncología

Tema: Conceptos básicos

Subtema: Escalas en oncología

Dificultad: 1/5

Un hombre de 81 años, independiente para las actividades básicas, con hipertensión y diabetes bien controladas, es diagnosticado de adenocarcinoma de próstata oligometastásico, con un PSA de 42 ng/mL y una única lesión ósea asintomática en el sacro. Su estado funcional (ECOG 1) es bueno, aunque presenta fragilidad leve y polifarmacia. El equipo médico debate distintas estrategias terapéuticas (tratamiento hormonal, radioterapia dirigida o vigilancia). Antes de decidir la mejor opción terapéutica, ¿qué aspectos deben considerarse de forma prioritaria en este paciente?

1. El nivel de PSA y el número de lesiones metastásicas detectadas.
2. La posibilidad de aplicar el tratamiento más agresivo disponible, dado que hay enfermedad metastásica.
3. Comorbilidades, el estado funcional y la expectativa de vida.
4. La edad cronológica del paciente como criterio principal para limitar el tratamiento.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 131 · MIR 2025 - 2026

Asignatura: Oncología

Tema: Genética del cáncer

Subtema: Biomarcadores en el cáncer

Dificultad: 2/5

¿Cuál es la técnica de elección para la determinación de la expresión de PD-L1 en la muestra tumoral?

1. Secuenciación masiva.
2. Inmunohistoquímica.
3. Western blot.
4. Hibridación in situ (FISH).

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 133 · MIR 2025 - 2026

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tratamiento biológico

Dificultad: 3/5

Paciente varón de 63 años con antecedentes de miastenia gravis. Ha sido diagnosticado recientemente de melanoma en estadio IV con extensa carga de la enfermedad, con afectación hepática múltiple, pulmonar bilateral y adenopatías generalizadas. Se realiza una determinación de BRAF por inmunohistoquímica, siendo positiva para V600E. ¿Cuál sería el tratamiento MÁS razonable teniendo en cuenta el riesgo/beneficio?

1. Pembrolizumab.
2. Nivolumab.
3. Dabrafenib-trametinib.
4. Nivolumab-ipilimumab.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 106 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento radioterápico en oncología

Subtema: Conceptos generales

Dificultad: 4/5

Mujer de 46 años que tras 10 años de mastectomía derecha con vaciamiento ganglionar seguida de quimioterapia y radioterapia presenta linfedema de brazo derecho de larga evolución con importante edema y empastamiento sin signos de celulitis. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas NO está recomendada?

1. Realización de actividad física con elevación del miembro superior derecho.
2. Terapia física con fisioterapia descongestiva.
3. Diuréticos para reducir edema.
4. Liposucción.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 119 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tratamiento biológico

Dificultad: 4/5

Un hombre con diagnóstico de melanoma avanzado y en tratamiento con nivolumab (fármaco anti-PD-1) desarrolla elevación de las transaminasas siete veces los valores normales, junto con elevación de la bilirrubina total (2,3 mg/dL). Se han descartado cuadros infecciosos y no ha mejorado tras suspender el fármaco. A este respecto, señale la afirmación CORRECTA:

1. Es una hepatitis inmunomediada por nivolumab y es indistinguible de una hepatitis autoinmune.
2. La reintroducción del fármaco una vez resuelta conlleva la reaparición del cuadro en la mayoría de los casos.
3. Los corticoides a dosis de 1 mg/kg de prednisona o equivalente son el tratamiento de elección en esta situación.
4. La aparición de esta entidad es tardía, generalmente meses después de iniciado el tratamiento.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 139 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología mamaria

Subtema: Cáncer de mama

Dificultad: 3/5

Con respecto a los subtipos moleculares de cáncer de mama, señale la afirmación CORRECTA:

1. El cáncer de mama triple negativo es el subtipo más frecuente.
2. El cáncer de mama HER-2+ es el subtipo menos agresivo.
3. El cáncer de mama luminal A es el subtipo más raro.
4. El cáncer de mama triple negativo es el subtipo más agresivo.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 141 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tratamiento biológico

Dificultad: 3/5

¿A cuál de las siguientes proteínas presentes en la superficie celular se une el fármaco pembrolizumab?

1. PD-1.
2. PD-L1.
3. CTLA4.
4. HER-2.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 143 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Digestivo

Tema: Cáncer colorrectal esporádico

Subtema: Tratamiento del cáncer colorrectal esporádico

Dificultad: 3/5

En un paciente con cáncer colorrectal metastásico irresecable RAS nativo y con pérdida de expresión de proteínas reparadoras del ADN (MSI-H). ¿Cuál debe ser el tratamiento de elección de primera línea?

1. Quimioterapia + Anti-EGFR.
2. Inmunoterapia.
3. Quimioterapia.
4. Quimioterapia + Anti-VEGFR.

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 194 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Anatomía Patológica

Tema: Conceptos generales

Subtema: Clasificación tumoral basada en la histología

Dificultad: 4/5

En un paciente diagnosticado de una lesión tumoral ósea maligna que ha recibido tratamiento neoadyuvante, se realiza resección de la pieza y posterior biopsia para su análisis anatomopatológico. Indique, de las siguientes, ¿cuál es la información MÁS relevante para el pronóstico del paciente?

1. Tasa de necrosis en la pieza por efecto de terapia neoadyuvante.
2. Número de células tumorales en fase G0 de no división o interfase.
3. Porcentaje de células gigantes que se encuentran en la lesión.
4. Cantidad de células no estromales que componen el tumor.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 203 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Urología

Tema: Hiperplasia prostática benigna y carcinoma prostático

Subtema: Carcinoma prostático

Dificultad: 3/5

Hombre de 57 años con buen estado general, tiene un PSA de 13 ng/mL y tacto rectal pétreo. El estudio diagnóstico revela cáncer de próstata de alto riesgo, Gleason 9, metastásico, con afectación ósea (más de 8 lesiones en el esqueleto axial) y metástasis hepáticas. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento inicial indicado en la actualidad?

1. Prostatectomía radical con linfadenectomía extendida y resección de las metástasis.
2. Radioterapia externa pélvica y radioterapia estereotóxica de las metástasis.
3. Braquiterapia pélvica de alta tasa.
4. Antiandrógenos inicialmente más análogos de la LHRH + enzalutamida + docetaxel.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 153 · MIR 2023 - 2024

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tipos de quimioterapia

Dificultad: 3/5

¿Cuál de los siguientes datos NO es relevante antes de iniciar un tratamiento adyuvante con fluorouracilo a un paciente intervenido de cáncer de colon?

1. El aclaramiento de creatinina.
2. Determinación de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD).
3. Síntomas previos de neurotoxicidad.
4. Antecedentes de cardiopatía isquémica.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 203 · MIR 2023 - 2024

Asignatura: Oncología

Tema: Genética del cáncer

Subtema: Biomarcadores en el cáncer

Dificultad: 4/5

En un paciente con cáncer de colon metastásico, ¿cuál de las siguientes determinaciones moleculares se deben realizar antes de comenzar el tratamiento sistémico?

1. EGFR, NRAS, KRAS, proteínas reparadoras, HER2.
2. NRAS, KRAS, BRAF, proteínas reparadoras.
3. EGFR, NRAS, KRAS, BRAF, proteínas reparadoras.
4. NRAS, KRAS, BRAF, proteínas reparadoras, PI3K.

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 144 · MIR 2022 - 2023

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento radioterápico en oncología

Subtema: Protonterapia

Dificultad: 3/5

En relación con el tratamiento con radioterapia, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Puede ser una alternativa de tratamiento curativo en diversas situaciones en oncología.
2. Se emplea también para determinadas patologías benignas.
3. Está contraindicada para el tratamiento de tumores pediátricos.
4. Tiene una demostrada utilidad en el control del dolor por metástasis óseas.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 191 · MIR 2022 - 2023

Asignatura: Oncología

Tema: Conceptos básicos

Subtema: Escalas en oncología

Dificultad: 3/5

Paciente de 50 años que consulta por presentar una adenopatía localizada. ¿Qué localización de las siguientes debe hacer sospechar un mayor riesgo de malignidad?:

1. Retroauricular.
2. Supraclavicular.
3. Axilar.
4. Inguinal.

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 144 · MIR 2021 - 2022

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Principios básicos de la quimioterapia

Dificultad: 4/5

¿Cuál es el objetivo PRINCIPAL del tratamiento adyuvante del cáncer de mama?

1. Incremento de la supervivencia global.
2. Transformar tumores no resecables en resecables para la cirugía.
3. Aumentar la supervivencia libre de progresión.
4. Mejorar el control de síntomas.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 158 · MIR 2021 - 2022

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento radioterápico en oncología

Subtema: Técnicas

Dificultad: 3/5

De entre los siguientes, señale el tumor en el que la braquiterapia NO es una alternativa efectiva de tratamiento:

1. Adenocarcinoma de endometrio estadio I-B grado 2.
2. Carcinoma ductal infiltrante de mama tras intervención quirúrgica del lecho tumoral con margen cercano.
3. Glioblastoma multiforme resecado parcialmente.
4. Adenocarcinoma de próstata T1N0M0 Gleason 6.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 71 · MIR 2019 - 2020

Asignatura: Oncología

Tema: Genética del cáncer

Subtema: Biomarcadores en el cáncer

Dificultad: 3/5

Paciente de 40 años, con exploración física normal, en el que se ha puesto en evidencia en la tomografía computarizada una masa mediastínica y un nódulo hepático, y en la analítica una elevación sérica de lactato deshidrogenasa (LDH), beta-gonadotropina coriónica humana (beta-HCG) y alfafetoproteína.

¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

1. Hepatocarcinoma metastásico.
2. Seminoma extragonadal metastásico.
3. Linfoma mediastínico.
4. Cáncer de células germinales no seminomatoso extragonadal metastásico.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 73 · MIR 2019 - 2020

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Introducción

Dificultad: 4/5

La radioterapia en el cáncer de mama NO está indicada en:

1. Carcinoma in situ post-tumorectomía.
2. Estadio I post-mastectomía.
3. Estadios localmente avanzados.
4. Enfermedad metastásica sintomática.

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 185 · MIR 2019 - 2020

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tratamiento biológico

Dificultad: 4/5

En 2018 James Allison y Tasuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de las moléculas CTLA4 y PD1, que supone un gran avance en la inmunoterapia del cáncer. El tratamiento de pacientes con cáncer con anticuerpos anti-PD1 (como pembrolizumab) se basa en que:

1. El anticuerpo anti-PD1 se une al receptor PD1 expresado en células tumorales induciendo su muerte por apoptosis.
2. El anticuerpo anti-PD1 actúa como puente entre la célula tumoral y sus ligandos en los linfocitos T, favoreciendo la destrucción del tumor por linfocitos citotóxicos.
3. El anticuerpo anti-PD1 favorece la opsonización de la célula tumoral y su eliminación por las células fagocíticas.
4. El anticuerpo anti-PD1 bloquea el funcionamiento del receptor PD1, que actúa como un regulador negativo de la actividad de los linfocitos T, permitiendo así su activación.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 213 · MIR 2018 - 2019

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tratamiento endocrino

Dificultad: 2/5

Una paciente de 32 años acude a su consulta tras ser intervenida de un cáncer de mama derecho mediante cirugía conservadora. El informe de anatomía patológica informa de carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado de 2 cm con afectación de 8 de 12 ganglios aislados. Receptores de estrógenos y progesterona positivos. Her-2 negativo. El tratamiento adyuvante indicado incluiría todas las opciones EXCEPTO:

1. Quimioterapia sistémica.
2. Radioterapia sobre lecho mamario.
3. Hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa.
4. Radioterapia sobre hueso axilar.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 214 · MIR 2018 - 2019

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tipos de quimioterapia

Dificultad: 3/5

Mujer de 45 años sin antecedentes de interés, con el diagnóstico de cáncer de colon con afectación hepática, con buen estado general, sin alteraciones analíticas. Comienza tratamiento sistémico paliativo en primera línea con oxaliplatino, 5-fluorouracilo y bevacizumab, sin ninguna complicación. Tras 4 meses de tratamiento y respuesta parcial de la enfermedad, acude a Urgencias por cefalea, alteraciones visuales, tendencia al sueño e hipertensión arterial grave. Se realiza TC con contraste intravenoso y se evidencia una alteración bilateral extensa en la sustancia blanca con edema cerebral en ambos lóbulos occipitales y en cerebelo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica MÁS probable?

1. Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible.
2. Meningitis carcinomatosa.
3. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
4. Toxicidad neurológica por 5-fluorouracilo.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 215 · MIR 2018 - 2019

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tratamiento biológico

Dificultad: 1/5

Los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), como el cetuximab o panitumumab, están indicados en una de las siguientes situaciones. Señálela:

1. Tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de colon estadio III y presencia de sobreexpresión de EGFR.
2. Tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de recto estadio III en combinación con radioterapia, con mutaciones en K-RAS y/o N-RAS.
3. Tratamiento adyuvante en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de recto estadios II y III, con sobreexpresión de EGFR.
4. Tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal avanzado (estadio IV) sin mutaciones en K-RAS ni N-RAS.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 214 · MIR 2016 - 2017

Asignatura: Cirugía General

Tema: Metástasis hepáticas y carcinomatosis peritoneal

Subtema: Metástasis hepáticas

Dificultad: 3/5

Hombre de 65 años, sin otras enfermedades asociadas y con buen estado general, que presenta una recaída metastásica hepática de un adenocarcinoma de colon por el que había sido intervenido hace 3 años. La TC demuestra que las lesiones hepáticas son múltiples y afectan todos los segmentos. El estudio molecular de la biopsia hepática muestra mutaciones de K-RAS. ¿Qué tratamiento inicial considera MÁS adecuado para este paciente?

1. Trasplante hepático.
2. Quimioterapia y anticuerpo anti-EGFR (cetuximab).
3. Quimioterapia protocolo FOLFOX.
4. Tratamiento paliativo de los síntomas sin administración de quimioterapia.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 216 · MIR 2014 - 2015

Asignatura: Oncología

Tema: Genética del cáncer

Subtema: Oncogenes, genes supresores de tumores y transformación celular

Dificultad: 3/5

¿Cuál de los siguientes es un oncogén cuyo producto de transcripción es un receptor de membrana con actividad tirosinquinasa de un factor de crecimiento?

1. HER2/Neu.
2. p53.
3. MYC.
4. APC.
5. Ras.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 121 · MIR 2011 - 2012

Asignatura: Oncología

Tema: Conceptos básicos

Dificultad: 2/5

La función más importante de las isoformas FGF-1 y FGF-2 de los factores de crecimiento fibroblástico (FGFs) es:

1. Estimular la síntesis de colágeno y la proliferación de los fibroblastos.
2. Estimular la síntesis de colágeno y la proliferación de los queratinocitos.
3. Estimular la síntesis de colágeno y la migración de los queratinocitos.
4. Estimular la angiogénesis.
5. Estimular la epitelización.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 123 · MIR 2011 - 2012

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Subtema: Tratamiento biológico

Dificultad: 2/5

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal antiEGFR empleado en el tratamiento del cáncer colorrectal izquierdo avanzado. Existe un efecto secundario característico de este fármaco cuya intensidad es directamente proporcional a la eficacia antitumoral, señale cuál:

1. Hipertensión arterial.
2. Ictus.
3. Hemorragia.
4. Infarto agudo de miocardio.
5. Rash cutáneo acneiforme.

Respuesta correcta: opción 5.

Pregunta 118 · MIR 2010 - 2011

Asignatura: Oncología

Tema: Conceptos básicos

Dificultad: 3/5

Paciente de 39 años de edad sin antecedentes familiares ni personales de interés. Consulta por un cuadro de un mes de evolución caracterizado por un síndrome constitucional, acompañado de dolor en hipocondrio derecho y hemicráneo izquierdo. La exploración física pone de manifiesto una lesión dolorosa y dura en región parietal izquierda así como una hepatomegalia dolorosa. La radiografía simple de cráneo muestra una lesión lítica, con efecto de masa en parietal izquierdo de unos 5 cm de diámetro, y la ecografía abdominal varias lesiones ocupantes de espacio en hígado. ¿Cuál sería la primera exploración que realizaría?

1. Marcadores tumorales.
2. TC de cuerpo entero.
3. PET-TC.
4. Gastroscoopia + colonoscopia.
5. Una PAAF.

Respuesta correcta: opción 5.

Pregunta 123 · MIR 2009 - 2010

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Dificultad: 2/5

Con referencia al tratamiento del dolor agudo, señale la respuesta INCORRECTA entre las siguientes:

1. Los efectos secundarios de los opiáceos son frecuentes aunque no graves salvo la depresión respiratoria que se puede revertir con naloxona.
2. El primer signo de sobredosificación de opiáceos es la somnolencia.
3. La mayoría de los opiáceos actúan sobre los receptores mu.
4. La normeperidina, metabolito de la petidina puede provocar hiperexcitabilidad refractaria a la naloxona.
5. La combinación de opiáceos e inhibidores de la ciclooxigenasa (AINE) no aporta valor en el tratamiento del dolor agudo posoperatorio.

Respuesta correcta: opción 5.

Pregunta 125 · MIR 2009 - 2010

Asignatura: Oncología

Tema: Conceptos básicos

Dificultad: 2/5

En la decisión terapéutica de un paciente neoplásico es fundamental determinar el estadio tumoral. ¿Cuál o cuáles son los elementos claves para determinar el estadio de diseminación de un tumor?

1. Determinación sérica de los niveles de los marcadores tumorales propios del tumor.
2. Valoración de la afectación tumoral del denominado ganglio centinela.
3. Evaluación del tipo histológico del tumor en una biopsia o pieza quirúrgica de extirpación del tumor.
4. Determinación del tamaño tumoral, afección de los ganglios linfáticos y de la presencia de metástasis.
5. Establecimiento del grado de diferenciación tumoral en una biopsia del tumor.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 127 · MIR 2009 - 2010

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento farmacológico en oncología

Dificultad: 5/5

Una paciente con un carcinoma de mama ha sido tratada con quimioterapia que incluye adriamicina y actualmente está recibiendo tratamiento con trastuzumab. ¿Cuál de los siguientes estudios cree que es necesario realizar de forma regular en su seguimiento actual?

1. Radiografía de abdomen.
2. Doppler venoso.
3. Niveles sanguíneos de magnesio.
4. Ecocardiograma.
5. Electroforesis en sangre.

Respuesta correcta: opción 4.

Bloque 2 / 12 preguntas

Pregunta 12 · MIR 2025 - 2026

Asignatura: Oncología

Tema: Urgencias oncológicas

Subtema: Síndrome de compresión medular

Dificultad: 2/5

Paciente de 70 años fumador de dos paquetes de cigarrillos al día. Acude a Urgencias por disnea, plétora facial, edema en esclavina y cianosis. Se realiza una tomografía axial computarizada (TAC) de tórax en el que se observan las siguientes imágenes vinculadas. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

Imagen 12a



Imagen 12b



1. Carcinoma microcítico de pulmón.
2. Linfoma de Hodgkin.
3. Metástasis de carcinoma no microcítico de pulmón.
4. Carcinoma tímico.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 132 · MIR 2025 - 2026

Asignatura: Oncología

Tema: Urgencias oncológicas

Subtema: Síndrome de compresión medular

Dificultad: 5/5

Varón de 63 años con carcinoma de próstata resistente a la castración con metástasis ganglionares y óseas múltiples. Actualmente, se encuentra en tratamiento con enzalutamida. Acude a consulta por dolor lumbar de reciente aparición, aunque refiere no haber tomado analgesia. Reconoce episodios de incontinencia urinaria. A la exploración se detecta un ligero déficit motor en la extremidad inferior izquierda (3/5). ¿Cuál sería la MEJOR actitud que seguir con este paciente?

1. Realización de una resonancia magnética urgente.
2. Administración de dexametasona 10 mg.
3. Administración de AINE y reevaluación en 48 horas.
4. Realización de una radiografía simple de columna.

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 140 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Nefrología

Tema: Fracaso renal agudo

Subtema: Insuficiencia renal aguda parenquimatosa

Dificultad: 2/5

Mujer de 60 años con diagnóstico reciente de cáncer de mama metastásico con alta carga tumoral. Acude a Urgencias 48 horas después de haber recibido el primer ciclo de tratamiento, con cuadro de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, astenia intensa y letargia. En la analítica sanguínea presenta alteración de la función renal. ¿Cuál de las siguientes alteraciones analíticas esperaríamos encontrar también?

1. Hipouricemia.
2. Hiperpotasemia.
3. Hipofosfatemia.
4. Hipercalcemia.

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 142 · MIR 2024 - 2025

Asignatura: Oncología

Tema: Urgencias oncológicas

Subtema: Neutropenia febril

Dificultad: 2/5

¿Cuál de los siguientes pacientes en tratamiento con quimioterapia cumple criterios de neutropenia febril?

1. Mujer de 38 años intervenida de cáncer de mama en curso de quimioterapia adyuvante que acude a Urgencias por temperatura de 38,5 °C, odinofagia, rinorrea y buen estado general. Neutrófilos 400/mm³.
2. Mujer de 68 años intervenida de cáncer de colon estadio IV en curso de quimioterapia de primera línea que acude a Urgencias por temperatura de 37,8 °C, diarrea y mucositis grado 2. Hemodinámicamente estable. Neutrófilos 300/mm³.
3. Hombre de 50 años intervenido de adenocarcinoma gástrico en curso de quimioterapia adyuvante que acude a Urgencias por escalofríos y temperatura de 37,5 °C sin otra sintomatología acompañante. Neutrófilos 600/mm³.
4. Hombre de 65 años afecto de adenocarcinoma gástrico metastásico en curso de quimioterapia de segunda línea con ECOG 1 que acude a Urgencias por temperatura de 38,6 °C y diarrea grado 1. Neutrófilos 700/mm³.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 155 · MIR 2021 - 2022

Asignatura: Oncología

Tema: Urgencias oncológicas

Subtema: Hipercalcemia maligna

Dificultad: 3/5

¿Cuál de las siguientes es la complicación metabólica MÁS frecuente en el cáncer?

1. Hiponatremia.
2. Hiperuricemia.
3. Hiperfosfatemia.
4. Hipercalcemia.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 156 · MIR 2021 - 2022

Asignatura: Oncología

Tema: Urgencias oncológicas

Subtema: Síndrome de vena cava superior

Dificultad: 2/5

En relación con la compresión medular secundaria a infiltración neoplásica de la médula espinal en pacientes con cáncer, es INCORRECTO que:

1. La laminectomía quirúrgica y la radioterapia, sola o complementaria a la cirugía, consiguen una recuperación neurológica inferior al 20%.
2. El tratamiento precoz con corticoides reduce el edema vasogénico y limita la progresión de la lesión medular.
3. Los síntomas más frecuentes son la paraparesia y la reducción de la sensibilidad distal al segmento medular comprimido.
4. La resonancia magnética es la prueba diagnóstica de elección para la confirmación diagnóstica y la identificación del nivel de compresión.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 165 · MIR 2013 - 2014

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento del paciente terminal. Cuidados paliativos

Subtema: Tratamiento de las complicaciones más frecuente

Dificultad: 5/5

Una mujer de 90 años demenciada, incontinente e inmovilizada por hemiparesia, presenta una úlcera sacra de grado III. En la exploración vemos que está en la cama sobre una almohadilla húmeda y con una sonda de alimentación que está bien colocada. Se encuentra afebril y tiene un pulso y una tensión arterial normales. Tiene una úlcera sacra de 4 x 4 cm que se extiende hacia la fascia con exudado verde y piel normal que rodea la úlcera. ¿Cuál es la primera prioridad en los cuidados de esta paciente?:

1. Empezar tratamiento con antibióticos.
2. Cultivar el exudado del decúbito.
3. Aplicar vendajes semihúmedos de solución salina tres veces al día.
4. Hacer cambios posturales a la paciente cada dos horas.
5. Colocar una sonda urinaria permanente.

Respuesta correcta: opción 4.

Pregunta 129 · MIR 2012 - 2013

Asignatura: Bioética y Medicina Legal

Tema: Ética en el final de la vida. El paciente terminal

Subtema: Cuidados paliativos

Dificultad: 3/5

Paciente de 93 años, diagnosticado de adenocarcinoma de colon ascendente con carcinomatosis peritoneal, metástasis hepáticas y pulmonares. Encamado en su domicilio el 90% del día. Sigue tratamiento con morfina de liberación retardada, dexametasona 8 mg/día, lactulosa, parafina y un zolpidem a las 22 horas. Comienza con dolor cólico periumbilical, náuseas y vómitos alimentarios. Tras su evaluación es diagnosticado de obstrucción intestinal. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?:

1. Suspender fármacos por vía oral y preparar para realización de colonoscopia.
2. Administrar metoclopramida intravenosa para el control de vómitos y suspender laxantes y morfina hasta reevaluar evaluación clínica.
3. Suspender fármacos por vía oral y administrar morfina, haloperidol, dexametasona y bromuro de hioscina por vía subcutánea para el control de síntomas.
4. Suspender fármacos por vía oral y realizar tomografía axial computarizada para valorar cirugía urgente.
5. Suspender fármacos por vía oral y administrar fentanilo transdérmico para control del dolor y metoclopramida y dexametasona por vía intravenosa para control de vómitos.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 130 · MIR 2012 - 2013

Asignatura: Bioética y Medicina Legal

Tema: Ética en el final de la vida. El paciente terminal

Subtema: Cuidados paliativos

Dificultad: 4/5

En un paciente en situación terminal de enfermedad que precisa morfina para un correcto control sintomático, ¿cuál de las siguientes actuaciones, encaminadas al control del estreñimiento, está contraindicada?:

1. Pautar laxantes osmóticos.
2. Pautar laxantes estimulantes de la motilidad colónica.
3. Pautar fibra.
4. Pautar laxantes reblandecedores de heces.
5. Pautar laxantes vía rectal.

Respuesta correcta: opción 3.

Pregunta 129 · MIR 2009 - 2010

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento del paciente terminal. Cuidados paliativos

Dificultad: 2/5

En relación con el estreñimiento en el paciente con cáncer en situación paliativa, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Está provocado habitualmente por diversas causas.
2. Se debe descartar la hipocalcemia por su manejo específico.
3. La disminución de la actividad física contribuye a empeorar este síntoma.
4. La disminución de la ingesta de alimentos disminuye la masa fecal.
5. Muchos de los fármacos que se utilizan en esta fase, como la amitriptilina, contribuyen al estreñimiento.

Respuesta correcta: opción 2.

Pregunta 137 · MIR 2005 - 2006

Asignatura: Oncología

Tema: Urgencias oncológicas

Dificultad: 5/5

Señale cuál es, entre los siguientes, el tratamiento antiemético más adecuado en la obstrucción intestinal maligna completa refractaria:

1. Octreótido.
2. Metoclopramida.
3. Domperidona.
4. Cisaprida.
5. Enema de limpieza.

Respuesta correcta: opción 1.

Pregunta 139 · MIR 2004 - 2005

Asignatura: Oncología

Tema: Tratamiento del paciente terminal. Cuidados paliativos

Dificultad: 2/5

En el manejo de los “estertores de la agonía” está indicado:

1. El empleo de la fisioterapia respiratoria.
2. Forzar la hidratación con sueroterapia.
3. El empleo de la aspiración nasofaríngea continuada.
4. La administración de anticolinérgicos.
5. Evitar explicar a los familiares la etiología del síntoma por el impacto emocional de la situación.

Respuesta correcta: opción 4.